통풍, 지금 아플 때부터 평생 관리까지

발작이 왔을 때 무엇을 하고, 요산 약은 언제 시작해 얼마나 오래 먹는지 —
가장 많이 묻는 순서로

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

지금 아플 때 — 먼저 이 네 가지

빨리 알리고 · 관절을 쉬게 하고 · 냉찜질하고 · 드시던 요산 약은 그대로

1

최대한 빨리 알립니다

발작이 시작되면 **빨리** 알려 주세요. 통증을 가라앉히는 **불끄기 약**을 함께 씁니다.

드시던 요산 약에 급성 통증 약을 더하는 것입니다.

시작되면 바로 연락

2

관절을 쉬게 합니다

발작이 오면 다치지 않도록 아픈 관절을 **쉬게** 하세요.

아픈 관절에 무리를 주지 않는 것이 먼저입니다.

아픈 관절은 쉬기

3

찜질은 차갑게 합니다

아픈 부위는 **냉찜질**을 하세요.

핫팩·온찜질은 혈관을 넓혀 염증을 더 키웁니다.

온찜질 대신 냉찜질

4

드시던 요산 약은 그대로

발작이 와도 요산 약은 **그대로** 드세요. 스스로 끊지 않습니다.

끊으면 요산이 출렁여 통증이 오히려 오래갑니다.

스스로 끊지 않기

Tip · 아플 때 잰 요산 수치만으로 통풍이 아니라고 단정할 수 없어, 가라앉은 뒤 다시 잽니다.

근거 · ACR 2020 · EULAR 2016 · 대한류마티스학회

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

급성기 약은 세 가지 — 몸 상태를 보고 고릅니다

콩팥·위장·당뇨·심장 상태에 따라 가장 안전한 약을 선택합니다

콜히친 — 저용량으로

고용량과 효과는 비슷하고 부작용은 적습니다. 같이 먹으면 안 되는 약이 있어 복용 중인 약을 **알려 주세요**.

소염진통제

콩팥에 부담을 줄 수 있어 피하는 경우가 많습니다. 위장 출혈·부종·혈압 상승도 주의합니다.

스테로이드

콩팥이 나쁘거나 위장이 약하거나 피 묽게 하는 약을 드실 때 씁니다. 먹는 약·주사 모두 가능합니다. 혈당을 올리므로 **당뇨가 있으면** 미리 알려 주세요.



세 약의 효과는 비슷합니다. 어느 약이 센가가 아니라, 지금 내 몸에 가장 안전한 약으로 정합니다.

Tip · 두 가지를 함께 쓰면 부작용도 겹칠 수 있어 신중히 정합니다. 셋 다 어려우면 전문의 진료를 권합니다.

근거 · ACR 2020 · EULAR 2016 · APLAR 2021 · 대한류마티스학회

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

혈압약·아스피린도 통풍 진료 때 함께 봅니다

약을 임의로 바꾸지 말고 현재 복용 목록을 알려 주세요

이뇨제는 약 이름부터

히드로클로로티아지드를 드시면 알려 주세요. 다른 혈압약으로 바꾸는 것을 고려합니다. 혈압약을 선택할 때는 **로사탄**을 우선 고려할 수 있습니다.

저용량 아스피린

심혈관질환 예방 등 **적절한 이유로 복용 중이면 통풍 때문에 중단하지 않습니다.** 요산 수치에 영향을 주더라도 원래의 치료 목적을 함께 봅니다.

약과 생활을 함께

이뇨제·저용량 아스피린·사이클로스포린 등은 요산 배설에 영향을 줄 수 있어, 현재 먹는 약 목록을 진료 때 함께 확인합니다.

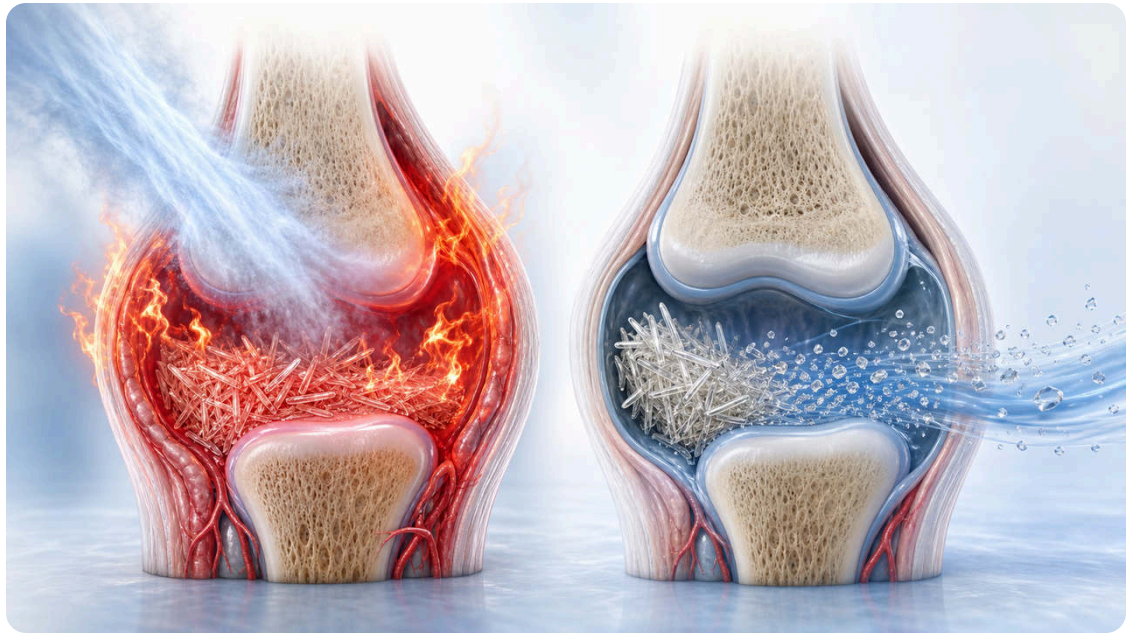
고혈압·이상지질혈증·당뇨·비만도 함께 관리합니다. 음주·과식·과당 음료 조절과 체중 관리가 통풍 치료에 연결됩니다.

통풍약과 동반질환 약의 목적을 함께 보고 계획합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

불끄기 약과 청소 약은 다릅니다

급성기에는 요산 약을 새로 시작하지 않습니다. 기존 복용자는 유지합니다 (아산28 김용길)



불끄기 약
발작의 통증과 염증을 가라앉힙니다

청소 약(요산 약)
쌓인 요산 결정을 녹여 냅니다

두 약은 하는 일이 다릅니다

통증을 가라앉히는 약과 요산을 녹여내는 약은 **별개**입니다. 이미 요산 약을 복용 중이면 발작 때 급성기 약을 더합니다. (아산28 김용길)

청소 약은 오래 유지합니다

요산 약은 조건이 맞으면 시작해 **고혈압 약처럼** 오래 드십니다.

발작이 와도 끊지 않습니다

이상반응이 없으면 발작 중에도 그대로 드세요. 끊으면 요산이 출렁여 통증이 오히려 오래갑니다.

Tip · 불끄기 약은 지금의 통증을, 청소 약은 다음 발작을 줄이는 일을 맡습니다.

근거 · ACR 2020 · EULAR 2016

요산 약 — 누가, 언제 시작하나

조건이 맞으면 시작해 오래 유지합니다 — 경우별로 정리했습니다

경우	이럴 때	어떻게
꼭 시작합니다	통풍결절이 만져질 때 · 뼈 손상이 있을 때 · 발작이 **1년에 두 번 이상**일 때	강하게 권고됩니다
상의해서 정합니다	콩팥병 3기 이상 · 요산 **9 mg/dL** 초과 · 요로결석 · 첫 발작이지만 위험 요인이 겹칠 때	의료진과 함께 정합니다
시작하는 때	발작이 가라앉고 **2~4주 뒤** 시작하는 방법이 널리 쓰입니다	학회마다 권고가 조금씩 다릅니다
증상 없이 요산만 높을 때	대개 약보다 **생활 관리**로 봅니다	요산결석이나 실제 통풍이 있으면 그 이유로 치료합니다

Tip · 요산 약을 시작할지는 수치 하나가 아니라 결절·발작 횟수·콩팥 상태를 함께 보고 정합니다.

근거 · ACR 2020 · EULAR 2016 · NICE NG219 2022 · 대한류마티스학회 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

요산 약 — 발작 이력과 시작 시점을 나눠 봅니다

새로 시작할 때와 이미 복용 중일 때의 계획이 다릅니다

급성기 치료 → **안정 후 3~4주** → **요산약 시작**

강하게 권하는 경우

통풍결절 1개 이상, 통풍으로 생긴 영상상 뼈 손상, **연 2회 이상** 발작이 있을 때입니다. 급성기가 안정된 뒤 시작합니다.

상의해서 정하는 경우

이전 발작이 여러 번 있지만 연 2회 미만인 경우도 상의합니다. 첫 발작이라도 **콩팥병 3기 이상·요산 >9 mg/dL·요로결석**이면 상의합니다.

증상 없이 요산만 높다면

관절염·결절이 없는 무증상 고요산혈증은 합병증 예방만을 목적으로 치료하지 않습니다. 단, 원인 미상의 신기능 저하 시 신기능 보호 목적의 투약을 고려합니다. 술·퓨린 섭취와 체중을 관리합니다.

연자 Q&A · 급성기 치료 1개월 후 시작을 권하며, 이미 먹는 요산약은 유지합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

요산 약 ① — 알로푸리놀과 페북소스타트

알로푸리놀이 1차약입니다 — 낮은 용량으로 시작해 목표까지 천천히 올립니다

알로푸리놀 — 첫 번째 약

요산을 낮추는 1차약입니다. 콩팥 기능이 떨어진 분에게도 1차로 강하게 권고되며, 이때는 시작 용량을 더 낮게 잡습니다.

낮게 시작해 천천히 올립니다

요산이 급하게 떨어지면 오히려 발작이 생기고 과민반응 위험도 올라갑니다. **2~5주** 간격으로 요산을 재며 목표까지 올립니다.

시작 전 유전자 검사

한국인은 시작 전 HLA-B*58:01 유전자 검사를 권합니다. 이 유전자를 가진 비율이 서양인보다 높아, 양성이면 다른 약으로 바꿉니다.

페북소스타트 — 두 번째 약

알로푸리놀이 맞지 않거나 효과가 부족할 때 씁니다. 심장 위험은 연구마다 결과가 달라, 심장병이 있으면 상의해 정합니다.

Tip · 처음부터 높은 용량으로 시작하지 않는 것은 발작과 부작용을 줄이기 위해서입니다.

근거 · ACR 2020 · EULAR 2016 · CPIC · 대한류마티스학회

콩팥 기능이 떨어지면 급성기와 예방을 나눕니다

아플 때의 단기 치료와 요산약 시작 때의 발작 예방은 다릅니다

콩팥 기능 확인 → 급성기 약 선택 → 예방 계획 따로

발작을 가라앉히는 치료

신기능 저하로 소염진통제가 어렵다면 **먹는 스테로이드(PD 30mg) 5일 이내**를 고려합니다. 감염 가능성도 봅니다. **1~2개 관절**이면 관절 안 주사도 선택할 수 있습니다. 콜히친도 콩팥 기능을 보고 씁니다.

연자 Q&A · 발작 예방은 별도

eGFR 30~59에서는 예방용 소염진통제·콜히친 병용이 어렵습니다. 스테로이드를 **3개월 이상** 쓰는 부담을 고려해, 요산약을 **저용량부터 1개월 간격**으로 서서히 올리는 방법을 설명했습니다.

요산약의 시작 용량과 증량 속도를 콩팥 기능에 맞춥니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

페북소스타트 — 심장 병력과 새 증상을 알립니다

강의에 소개된 안전성 안내의 환자 행동 수칙입니다

복용 전에 알려 주세요

심장질환이나 뇌졸중을 앓은 적이 있으면 반드시 알립니다. 페북소스타트의 심혈관 안전성은 연구마다 결과가 달라, 과거력과 약의 이득·위험을 함께 보고 선택합니다.

이런 증상은 즉시 진료

가슴통증·호흡곤란·비정상적인 심장박동, 몸의 저림, 갑작스러운 두통이 나타나면 즉시 진료받습니다.
강의는 이 증상과 대처법을 처방 때 안내하도록 설명했습니다.

스스로 약을 끊지 않습니다. 심장·뇌졸중 병력과 새 증상을 알려, 의료진이 위험과 이득을 함께 판단하도록 합니다.

병력은 처방 전에, 새 증상은 생긴 즉시 알립니다.

아산 28회 연수강좌 — 통풍 치료의 실제: 치료 전략과 임상 노하우(김용길)

알로푸리놀 발진 — 늦게 생기는 전신반응도 살핍니다

유전자 검사 음성이라도 시작 초기에 부작용 신호를 지켜봅니다

약 시작 → 2~8주 뒤 발현 가능 → 중단 뒤에도 악화 가능

알로푸리놀도 원인이 될 수 있습니다

약물 과민증후군(**DRESS**)은 약을 쓴 뒤 **2~8주** 지나 늦게 나타날 수 있습니다. 발열·발진과 얼굴 부종이 있으면 피부에만 생긴 문제로 넘기지 않습니다.

약을 멈춘 뒤에도 진료가 필요합니다

의심되는 원인 약은 **즉시 중단**하고 진료받습니다. 간 등 내부 장기를 침범할 수 있어 **혈액·간기능·콩팥기능 검사**가 필요합니다. 약을 끊은 뒤에도 악화될 수 있습니다.

간 침범이 가장 흔합니다. 발열·광범위 발진은 바로 진료받습니다.

아산 28회 연수강좌 — 피부 발진으로 보는 내과 질환(정준민)

요산 약 ②③ — 배설을 돕는 약, 잘 듣지 않을 때의 약

소변으로 요산을 내보내는 약과, 표준 치료로 목표에 닿지 않는 중증에만 쓰는 주사약

약	어떤 약인가	꼭 확인할 것
벤즈브로마론	소변으로 요산을 내보내는 약으로, 국내에서 실제로 쓸 수 있는 배설 촉진제입니다. 1차약이 맞지 않으면 교체를 상의합니다. 페북소스타트와 병합은 일반적으로 권고되지 않습니다 (아산28 김용길).	드물지만 중대한 **간 손상**이 있어 간기능을 정기적으로 봅니다 · 요로결석이 있던 분은 쓰지 않고, 쓸 때는 물을 충분히
페글로티카제	표준 요산 약으로 목표에 닿지 못한 **중증 결절 통풍**에 쓰는 정맥주사약입니다.	국내에는 아직 도입되지 않아 **전문센터 의뢰**가 원칙입니다
라스부리카제	이름이 비슷하지만 **통풍 약이 아닙니다**. 암 치료 중 특수한 상황에만 씁니다.	페글로티카제와 함께, 적혈구 효소(G6PD)가 부족한 분은 쓸 수 없습니다

Tip · 국내 허가·급여 현황은 처방 시점에 다시 확인합니다.

근거 · ACR 2020 · EULAR 2016

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

약 부작용은 '느껴지는 신호'로 기억하세요

아래 신호가 있으면 약을 멈추고 바로 오세요 — 혼자 참지 마세요

알로푸리놀 · 페북소스타트

원인 모를 열, 피부 발진, 입안 짓무름, 눈 충혈, 얼굴 부종 — **즉시 중단**하고 오세요.

콜히친

멈추지 않는 심한 설사, 쥐가 나는 듯한 복통, 근육 통증은 **독성 신호**입니다.

소염진통제 · 스테로이드

검은 변·토혈, 소변량이 갑자기 줄고 붓는 것, 열과 함께 온몸이 쳐지는 느낌.



유전자 검사가 음성이어도 위험이 완전히 없지는 않아, 시작 초기에 발진을 함께 지켜봅니다.

Tip · 알려 주시면 용량을 조절하거나 약을 바꿉니다. 정해진 날짜에 꾸준히 재진받으세요.

근거 · ACR 2020 · CPIC · 대한류마티스학회

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

페북소스타트와 간수치 — 약 조정은 함께 정합니다

연자 Q&A · 정해진 중단 수치 하나로 일률적으로 판단하지 않습니다

간수치 확인 → 원인·약 영향 평가 → 감량 후 추적

연자 Q&A · 시작 전 간수치가 높다면

페북소스타트가 간수치를 올릴 가능성도 생각합니다. 연자는 **높은 AST/ALT가 정상으로 회복된 뒤 시작**하는 편이 좋겠다고 답했습니다.

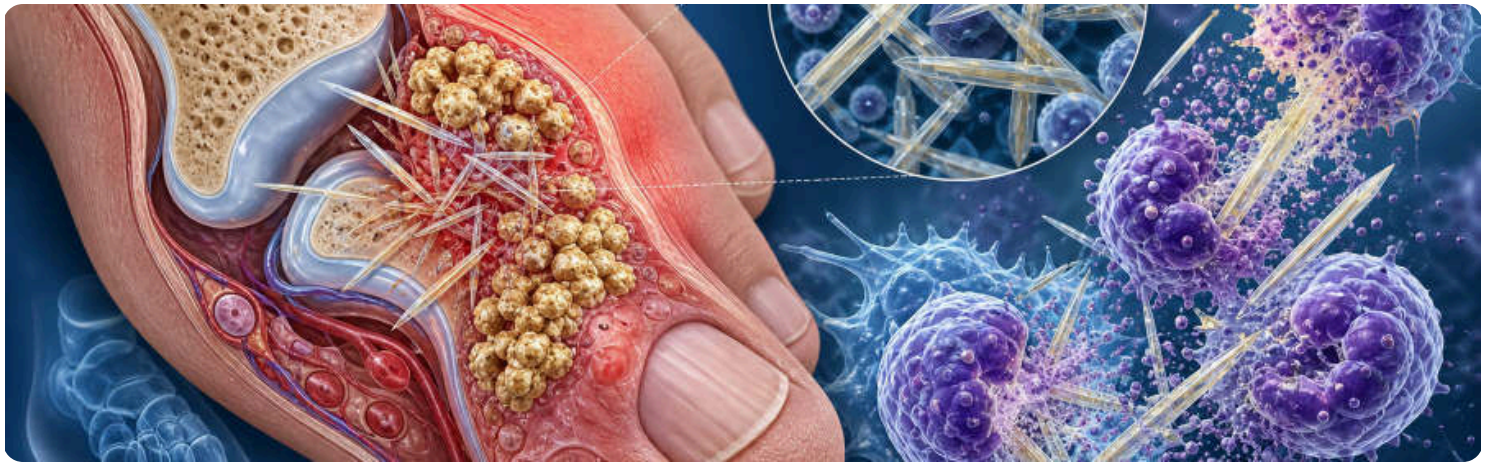
연자 Q&A · 복용 중 올라갔다면

AST/ALT가 정상 상한의 2배 이상이고 원인이 뚜렷하지 않으면 페북소스타트 **감량을 시도**할 수 있다고 답했습니다. 약을 중단하면 발작 위험이 높아져, 중단은 신중히 판단합니다.

검사 결과를 보며 원인과 약의 영향을 함께 평가합니다.

요산 약을 시작하면 처음엔 발작이 늘 수 있습니다

실패가 아니라 예정된 과정 — 그래서 '발작을 막는 약'을 같이 씁니다



3~6개월

요산 약을 시작하거나 올릴 때, 발작을 막는 약(저용량 콜히친 또는 저용량 소염진통제)을 함께 쓰는 최소 기간

⚠ 왜 같이 쓰나

요산이 초기에 급하게 내려가면 오히려 발작이 생길 수 있어, 낮은 용량부터 시작하고 예방약을 처음부터 같이 씁니다.

언제 멈추나

결절이 있거나 발작이 이어지면 더 늘립니다. 목표 수치에 닿고 발작이 없으면 **예방약만** 멈춥니다.

Tip · 굶거나 극단적인 저탄수화물·고지방 식사는 오히려 발작을 부릅니다. 체중은 천천히 줄이세요.

근거 · ACR 2020 · EULAR 2016 · 대한류마티스학회

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

콩팥·심장이 안 좋으면 무엇이 달라지나

약을 못 쓰는 것이 아니라, 고르는 약과 시작 용량이 달라집니다

이럴 때	이렇게 달라집니다
콩팥이 안 좋을 때 · 발작	소염진통제 대신 **스테로이드** 소염진통제는 콩팥에 부담을 줄 수 있어 피하는 경우가 많고, 스테로이드를 먹는 약·주사로 씁니다
콩팥이 안 좋을 때 · 요산 약	알로푸리놀은 그대로 **1차약** 시작 용량만 더 낮추고, 요산을 재면서 올립니다
심장병이 있을 때	**알로푸리놀**을 먼저 고려 페북소스타트는 심장병이 있는 분에서 위험이 논쟁 중입니다
스스로 끊고 싶을 때	끊기 전에 **먼저 상의** 임의로 끊으면 오히려 위험이 커질 수 있다는 자료가 있습니다
증상 없이 요산만 높을 때	대개 **약을 쓰지 않습니다** 요산 약이 콩팥병 진행을 늦춘다는 근거가 부족합니다

Tip · 특히 조심할 분 — 고령, 콩팥병·심부전, 피 묽게 하는 약 복용, 위장관 출혈을 겪은 적이 있는 경우.

근거 · ACR 2020 · KDIGO · EULAR 2016

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

식사 — 무엇을 줄이고, 무엇은 그대로 드셔도 되나

동물성 퓨린과 술·단 음료는 줄이고, 콩·두부·버섯 같은 식물성 퓨린은 제한하지 않습니다

그대로 드셔도 되는 것

- **콩·두부·버섯·시금치**
  식물성 퓨린은 발작을 늘리지 않습니다
- **저지방 우유·요구르트**
  오히려 도움이 됩니다
- **커피**
  위험을 낮춘다는 연구가 있습니다
- **살코기 위주로 적정량**
  완전히 끊지 마세요
- **등푸른생선·해산물**
  적당한 양으로
- **천천히 체중 감량**
  굶는 다이어트는 금물

VS

줄여야 하는 것

- **맥주**
  술 중에서 위험이 가장 큽니다
- **소주·양주**
  독주도 요산과 발작을 늘립니다
- **와인**
  와인도 발작을 유발할 수 있어 술 종류보다 전체 음주량을 줄입니다 (아산28 김용길)
- **콜라·주스·에너지드링크**
  단 음료를 줄이세요
- **곱창·간 등 내장류**
  진하게 우린 곰탕 국물도 줄이세요
- **체리·비타민 C 보충제로 약 대신하기**
  근거가 약합니다

Tip · 식사 조절은 약을 대신하지 않습니다 — 요산 약과 함께 갑니다.

근거 · 대규모 코호트·메타분석 · ACR 2020

목표 수치와 기간, 그리고 바로 오셔야 하는 때

목표에 닿아도 약은 계속 유지합니다 — 콩팥·간기능도 함께 봅니다



6 mg/dL 미만

일반적인 목표 — 국내 지침도 같은 기준입니다

5 mg/dL 미만

통풍결절이 있거나 중증이면 더 낮게 두기도 합니다

2~5 주

시작·증량 중 검사 간격 — 안정되면 6개월쯤마다

얼마나 오래 먹나

목표에 닿아도 대개 **오래** 드십니다. 결정은 서서히 녹아, 일찍 끊으면 다시 쌓입니다.

임의로 끊으면

요산이 급격히 변해 관절에 쌓인 결정이 흔들리고 통증이 훨씬 오래갑니다. 상의해 정합니다.

바로 오셔야 하는 때

열이 나며 여러 관절이 한꺼번에 아프거나, 한 관절이 갑자기 심해지고 온몸이 쳐질 때.

그림 · 요산 재기 → 결정 녹이기 → 꾸준히 복용 → 정기 검사 → 관절 지키기.

근거 · ACR 2020 · EULAR 2016 · NICE NG219 2022 · 대한류마티스학회 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

불끄기 약으로 통증을 잡고, 청소 약으로 요산을 낮춥니다

목표는 6 mg/dL 미만 — 꾸준히 유지하면 결절과 발작을 줄일 수 있습니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토 08:30~13:30
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

이 자료의 성격

통풍으로 치료 중인 분을 위한 설명자료입니다. 약의 선택과 용량은 담당 의사와 정하고, 발작 때 할 일은 통풍 안내문에 정리했습니다.

참고한 자료

미국류마티스학회(ACR) 2020 · 유럽류마티스학회(EULAR) 2016 · 대한류마티스학회 2022 · 영국 NICE NG219 2022 · 아시아태평양류마티스학회(APLAR) 2021 · CPIC 유전자 지침 · KDIGO

다시 보기 · 카톡 공유